

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КЗ «ЗОШПО» ЗОР

Едуард ГУГНІН



**ЗРАЗОК КОНТРОЛЬНО-ОЦІНЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
ЗА ПРОФЕСІЙНОЮ КВАЛІФІКАЦІЄЮ
«ФАХІВЕЦЬ ІЗ СУПРОВОДУ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА
ДЕМОБІЛІЗОВАНИХ ОСІБ»**

Запоріжжя 2026

Контрольно-оцінювальні матеріали (тестові завдання) варіант 1

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Який нормативний акт є базовим при оформленні та розгляді письмових пропозицій, заяв і скарг в Україні?

- А. Закон України «Про доступ до публічної інформації».
- Б. Закон України «Про інформацію».
- В. Закон України «Про звернення громадян».
- Г. Кодекс законів про працю України.

2. Який максимальний термін розгляду звернень громадян, що не потребують додаткового вивчення?

- А. Невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня отримання.
- Б. 30 днів з моменту офіційної реєстрації в журналі вхідної кореспонденції.
- В. 45 календарних днів з урахуванням можливості продовження терміну.
- Г. 10 робочих днів з дня прийняття рішення про розгляд звернення.

3. Яке основне призначення кваліфікованого електронного підпису (КЕП)?

- А. Шифрування повідомлень електронної пошти та захист каналів зв'язку.
- Б. Ідентифікація підписувача та забезпечення юридичної сили електронного документа.
- В. Забезпечення безперервного доступу до державних інформаційних веб-ресурсів.
- Г. Створення резервних копій та архівування службових електронних документів.

4. Які дії має здійснити фахівець при отриманні усного звернення від ветерана на особистому прийомі?

- А. Зафіксувати звернення в журналі обліку та/або ввести в електронну базу.
- Б. Надати роз'яснення усно, не реєструючи факт звернення для оптимізації обліку.
- В. Рекомендувати ветерану звернутися письмово через поштове відділення.
- Г. Передати вирішення питання до юридичного відділу.

5. Що таке Єдиний державний реєстр ветеранів війни (ЄДРВВ)?

А. Державна інформаційно-телекомунікаційна система для збирання, реєстрації та збереження інформації про ветеранів.

- Б. Друковане довідкове видання з адресами та контактами ветеранських організацій.
- В. Загальнодоступна база даних вакансій для демобілізованих військовослужбовців.
- Г. Міжнародна база даних обліку військовослужбовців країн-партнерів.

6. Який закон України є основним у сфері захисту особистих даних ветеранів?

- А. Закон України «Про захист персональних даних».
- Б. Закон України «Про національну безпеку України».
- В. Закон України «Про захист прав споживачів».
- Г. Закон України «Про електронні довірчі послуги».

7. Що є грубим порушенням правил обробки персональних даних?

- А. Збір та накопичення персональних даних у мінімально необхідному обсязі.
- Б. Ознайомлення суб'єкта персональних даних з його правами під підпис.
- В. Знищення персональних даних після закінчення встановленого терміну їх зберігання.
- Г. Передача контактних та персональних даних ветерана третім особам без його згоди.

8. Хто є розпорядником Єдиного державного реєстру ветеранів війни?

- А. Міністерство оборони України.
- Б. Пенсійний фонд України.
- В. Міністерство соціальної політики України.
- Г. Міністерство у справах ветеранів України.

9. Яка обов'язкова умова для обробки персональних даних ветерана?

- А. Отримання письмової або електронної згоди ветерана.
- Б. Наявність у ветерана посвідчення УБД.
- В. Усна згода родичів ветерана.
- Г. Дозвіл керівника установи.

10. Яка дія фахівця щоденно забезпечує інформаційну безпеку?

- А. Використовувати спільний пароль для робочої групи.
- Б. Зберігати копії документів на особистій флешці.
- В. Працювати під власним обліковим записом і блокувати екран, залишаючи робоче місце.
- Г. Надсилати файли на власну пошту для зручності.

11. Яка поведінка фахівця найбільше сприяє побудові довіри з ветераном?

- А. Уважно слухати, зберігати конфіденційність і поважати право ветерана самостійно ухвалювати рішення.
- Б. Активно підтримувати ветерана, радити найкращі рішення та супроводжувати його в основних життєвих питаннях.
- В. Надавати детальні інструкції, пояснювати порядок дій і контролювати виконання домовленостей.
- Г. Запевняти ветерана, що його питання буде швидко вирішено, щоб знизити напруження.

12. Яка тактика фахівця є найбільш професійною, якщо ветеран демонструє виражене роздратування або гнів під час спілкування?

- А. Відповісти більш жорстким тоном, щоб швидко відновити контроль над ситуацією та позначити особисті межі.
- Б. Автоматично припинити консультацію й викликати охорону.
- В. Зберігати спокій, говорити рівним тоном, не провокувати конфлікт і застосовувати техніки деескалації.
- Г. Наполягати на обговоренні причин гніву.

13. Які прояви у поведінці ветерана можуть бути підставою для уважного реагування та рекомендації звернутися до профільного фахівця?

- А. Періодична втома, потреба в усамітненні, зниження інтересу до спілкування після напруженого дня.
- Б. Нав'язливі спогади, уникнення нагадувань про подію, напруженість, дратівливість і порушення сну.
- В. Обережність у нових контактах, прагнення контролювати ситуацію, поступове повернення до звичного режиму.
- Г. Емоційна стриманість, небажання детально говорити про службу, потреба в часі для адаптації.

14. З якою метою фахівцю потрібні навички кроскультурної комунікації у роботі з ветеранами?

- А. Для налагодження взаємодії з партнерами, волонтерами та представниками різних спільнот, які залучені до підтримки ветеранів.
- Б. Для врахування особливостей спілкування з ветеранами, які мають різний життєвий, професійний і соціальний досвід.
- В. Для побудови неупередженої та чутливої взаємодії з ветеранами різного мовного, культурного, релігійного, етнічного чи регіонального досвіду.
- Г. Для адаптації інформаційних матеріалів і консультацій до потреб різних груп отримувачів послуг.

15. Який метод найкраще підходить для систематизації інформації при виявленні потреб?

- А. Запам'ятовування почутого під час розмови.

- Б. Проведення аудіозапису на диктофон під час прийому.
- В. Залучення клієнта до проходження стандартизованих тестів особистості.
- Г. Структуроване інтерв'ю з використанням стандартизованої анкети .

16. Які особи належать до категорії «ветерани війни»?

- А. Лише військовослужбовці, які проходять службу в Збройних Силах України.
- Б. Особи, які проходили строкову службу в лавах армії в мирний час.
- В. Усі громадяни України, які проживали в зоні ведення бойових дій.
- Г. Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни .

17. Яка знижка на оплату житлово-комунальних послуг передбачена для учасників бойових дій (УБД)?

- А. 25% від встановленого тарифу на послуги.
- Б. 75%.
- В. 50% від встановленого тарифу на послуги.
- Г. 100% звільнення від сплати комунальних послуг.

18. Де ветеран може отримати послугу через сервіс «Я – ветеран»?

- А. У Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).
- Б. Виключно безпосередньо у департаментах Міністерства у справах ветеранів.
- В. У територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
- Г. У відділеннях Національної поліції України за місцем перебування.

19. Що таке державний вебпортал «є-Ветеран»?

А. Закрита соціальна онлайн-мережа для неформального спілкування військовослужбовців, ветеранів та волонтерських спільнот.

Б. Загальнонаціональний електронний реєстр приватних благодійних фондів, громадських організацій і міжнародних донорських програм.

В. Інформаційне медіа, основним призначенням якого є оперативне висвітлення подій на лінії фронту та публікація воєнної аналітики.

Г. Державний вебпортал, що надає ветеранам, ветеранкам і членам їхніх сімей доступ до інформації про статуси, пільги, гарантії та електронні послуги.

20. У чому полягає роль фахівця при взаємодії ветерана з медичними закладами?

А. Допомогти ветерану визначити маршрут звернення, підготувати документи й питання до лікаря, за потреби сприяти комунікації в межах своєї компетенції.

Б. Зібрати скарги ветерана, попередньо оцінити його стан і порадити найбільш доцільний варіант лікування.

В. Супроводжувати ветерана до медичного закладу та погоджувати з лікарем призначення, якщо ветеран просить про підтримку.

Г. Передати медичному закладу інформацію про ситуацію ветерана й рекомендувати першочерговість обстежень.

21. Що таке «маршрутизація» ветерана?

А. Створення алгоритму направлення до відповідних органів (ЦНАП, ПФУ тощо).

Б. Складання детальної карти проїзду до місць надання соціальних послуг.

В. Процедура переведення військовослужбовця між військовими частинами.

Г. Направлення ветерана на оздоровлення за туристичними путівками.

22. Хто несе остаточну відповідальність за прийняття рішень в процесі супроводу?

А. Фахівець із супроводу ветеранів війни.

Б. Керівник центру соціальної підтримки.

В. Медичний працівник або психотерапевт, який веде клієнта.

Г. Сам ветеран, оскільки фахівець виконує координуючу функцію.

23. Що є ключовим аспектом соціальної адаптації демобілізованого?

А. Підтримання субординації в родинних стосунках.

- Б. Професійна перепідготовка, пошук роботи або відкриття справи.
- В. Тимчасова ізоляція від цивільного оточення.
- Г. Відмова від передбачених законом пільг і компенсацій.

24. Який комплекс чинників може істотно ускладнювати соціальну адаптацію ветерана після повернення до цивільного життя?

- А. Недостатня поінформованість про послуги, складність оформлення документів і потреба в додаткових консультаціях.
- Б. Обмеження соціальних контактів, труднощі з адаптацією військового досвіду до цивільної роботи та наслідки травми.
- В. Зміна місця проживання, потреба у професійному навчанні та складність взаємодії з різними установами.
- Г. Тимчасова невизначеність планів, пошук роботи та необхідність відновлення звичного ритму життя.

25. Якщо ветеран хоче відкрити справу, що має зробити фахівець?

- А. Надати рекомендацію щодо відмови від бізнес-ініціативи через ризики.
- Б. Запропонувати залучення додаткових фінансових ресурсів.
- В. Розробити та написати детальний бізнес-план підприємства разом з ветераном.
- Г. Проінформувати про грантові програми (є-Робота), допомогти знайти курси.

26. Яку роль відіграє ветеранський спорт («Ігри Нескорених»)?

- А. Не відіграє суттєвої ролі у процесі реабілітації.
- Б. Є обов'язковою юридичною умовою для отримання державних пільг.
- В. Створює конкуренцію серед ветеранських організацій.
- Г. Сприяє реабілітації, соціалізації, відновленню психологічного стану.

27. Яка основна мета моніторингу в супроводі ветерана?

- А. Відстежувати зміни в ситуації ветерана, оцінювати виконання цілей і за потреби коригувати індивідуальний план супроводу.
- Б. Узагальнювати інформацію про надані послуги для підготовки звітності та планування роботи фахівця.
- В. Перевіряти, наскільки ветеран дотримується погоджених рекомендацій і строків виконання запланованих дій.
- Г. Аналізувати взаємодію ветерана з установами, до яких його було скеровано в межах супроводу.

28. З якою періодичністю здійснюється моніторинг плану супроводу?

- А. Тільки після повного завершення всіх запланованих заходів.
- Б. Регулярно, згідно з графіком, узгодженим з ветераном.
- В. Один раз на п'ять років у межах загальної інспекції.
- Г. Виключно у разі надходження офіційної скарги від ветерана.

29. Який інструмент доцільно використовувати для оцінювання задоволеності ветерана якістю отриманого супроводу?

- А. Аналіз виконання індивідуального плану та кількості послуг, які ветеран фактично отримав.
- Б. Обговорення результатів супроводу з фахівцями й установами, які були залучені до роботи з ветераном.
- В. Анкетування або структуроване інтерв'ю з ветераном щодо доступності, корисності та якості отриманої підтримки.
- Г. Узагальнення службових записів, звернень і результатів моніторингу після завершення супроводу.

30. Яка дія фахівця є найбільш коректною, якщо заплановані заходи супроводу не дають очікуваного результату?

А. Завершити супровід, оскільки відсутність швидкого результату свідчить про неефективність подальшої роботи.

Б. Продовжувати виконувати початковий план без змін, щоб не порушувати попередньо визначену послідовність дій.

В. Зафіксувати недостатню мотивацію ветерана як основну причину неефективності плану без додаткового аналізу ситуації.

Г. Разом із ветераном проаналізувати причини труднощів, уточнити актуальні потреби та за потреби переглянути план супроводу.

31. Який критерій є ключовим для успішного закриття кейсу ветерана?

А. Завершення встановленого строку супроводу незалежно від того, чи були досягнуті визначені цілі.

Б. Досягнення основних цілей індивідуального плану та достатній рівень самостійності ветерана у подальшому вирішенні своїх питань.

В. Припинення роботи фахівця із супроводу, який був закріплений за ветераном на початку ведення кейсу.

Г. Зміна ветераном місця реєстрації або фактичного проживання.

32. Дайте визначення поняттю «професійне вигорання»?

А. Тимчасове відчуття втоми після напруженого робочого дня.

Б. Прагнення змінити кваліфікацію або сферу професійної діяльності.

В. Стан фізичного, емоційного та розумового виснаження від тривалого стресу.

Г. Процес планового виходу на пенсію за вислугою років.

33. Який інструмент є найбільш системним для профілактики професійного вигорання фахівця?

А. Уникнення спілкування з клієнтами та ігнорування їхніх запитів.

Б. Регулярна участь у супервізійних групах, баланс роботи та життя.

В. Збільшення робочого навантаження для відволікання від стресу.

Г. Відпустка та повноцінні вихідні.

34. Що найточніше відображає зміст супервізії у контексті соціальної роботи?

А. Обговорення складних професійних ситуацій із керівником для контролю дотримання процедур і строків виконання завдань.

Б. Перевірка якості ведення документації, звітності та відповідності роботи фахівця посадовим обов'язкам.

В. Консультація з більш досвідченим колегою щодо правильності оформлення кейсу та подальшого маршруту клієнта.

Г. Аналіз професійних дій фахівця, підтримка рефлексії, пошук ефективних рішень і профілактика професійного виснаження.

35. Яка поведінка фахівця є найбільш етично коректною, якщо його особисті переконання не збігаються з рішенням ветерана?

А. Коректно повідомити ветерану про власну незгоду, після чого наполегливо рекомендувати альтернативне рішення, яке фахівець вважає більш доцільним.

Б. Залишатися професійно нейтральним, поважати автономію ветерана, надавати інформацію без тиску, а за ризику упередженого ставлення – ініціювати передачу кейсу іншому фахівцю.

В. Продовжити супровід, але зосередити подальшу роботу на поступовому формуванні у ветерана більш конструктивної, з погляду фахівця, позиції.

Г. Утриматися від обговорення теми, щодо якої виник конфлікт переконань, і надалі взаємодіяти з ветераном лише з питань, які не викликають професійного дискомфорту.

36. Як часто фахівець повинен підвищувати кваліфікацію?

- А. Один раз на рік за державні кошти.
- Б. Один раз на 5 років під час планової атестації.
- В. Не рідше ніж раз на 3 роки.
- Г. Підвищення кваліфікації не є обов'язковою умовою.

37. Єдина державна інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, захисту та знеособлення інформації про ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей таких осіб та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України це –

- А. Єдиний державний реєстр ветеранів війни.
- Б. Єдиний державний реєстр адміністрування потреб окремих груп осіб.
- В. Єдиний державний реєстр осіб, які постраждали внаслідок військових дій.
- Г. Єдиний державний реєстр військовослужбовців у запасі та резерві.

38. Відповідно до законодавства України, особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам надається знижка на оплату за користування комунальними послугами в розмірі:

- А. 100%.
- Б. 90% від встановленого тарифу на послуги.
- В. 75% від встановленого тарифу на послуги.
- Г. 50% від встановленого тарифу на послуги.

39. Стан благополуччя, за якого кожна особа може реалізувати свій власний потенціал, впоратися з життєвими стресами, продуктивно та плідно працювати, а також робити внесок у життя своєї спільноти – це:

- А. Соціальне здоров'я та висока працездатність.
- Б. Особистісне здоров'я та гармонійний розвиток.
- В. Психологічне благополуччя.
- Г. Психічне здоров'я.

40. Неспецифічна відповідь організму на бойові дії, яка становить собою комплекс психоемоційних, фізіологічних та поведінкових реакцій, що виникають у комбатантів безпосередньо під час бойових ситуацій:

- А. Бойовий стрес.
- Б. Гостра психотравма.
- В. Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР).
- Г. Бойова втома або перевтома.

41. Членів сімей осіб, які перебувають у зоні активних бойових дій, слід готувати до того, що після повернення сімейні стосунки:

- А. Будуть такими самими, як і до початку військової служби.
- Б. Зміняться через те, що ветеран війни та члени його сім'ї зазнали особистих змін; потрібен буде період адаптації.
- В. Стануть неможливими через обов'язкову наявність ПТСР у ветерана війни.
- Г. Автоматично покращаться та стануть безконфліктними.

42. У разі нападу тремтіння (під час гострої реакції на стрес) слід:

- А. Міцно обійняти людину і намагатися силою стримувати тремтіння.
- Б. Закутати людину у теплу ковдру та дати випити гарячого чаю.
- В. Не стримувати тремтіння, посилити його, бути поруч із людиною до закінчення нападу.
- Г. негайно дати сильнодіючі заспокійливі.

43. Які особливі програми підтримки зайнятості для ветеранів війни є в Україні?

А. Центр зайнятості випадковим чином відбирає вакансії для ветеранів війни із загального списку.

Б. Центр зайнятості забезпечує ветеранів війни контактами роботодавців, а далі все залежить від самого ветерана.

В. Центр зайнятості надає ветеранам війни послуги з професійної орієнтації, включаючи визначення найбільш відповідних професій, підготовку резюме та проходження інтерв'ю.

Г. Центр зайнятості надає ветеранам війни гарантію працевлаштування у певних сферах.

44. Зазначте правильну послідовність реалізації програмно-цільового методу формування місцевих бюджетів:

А. Визначення проблем; планування заходів; впровадження заходів; моніторинг результатів; аналіз досяжної мети.

Б. Визначення проблем; впровадження заходів без попереднього планування.

В. Розрахунок залишків коштів; впровадження заходів; моніторинг результатів; аналіз досяжної мети.

Г. Розрахунок залишків коштів; визначення проблем; планування заходів; впровадження заходів.

45. Чим відрізняється супровід членів сім'ї загиблого Захисника?

А. Не потребує складання індивідуального плану супроводу.

Б. Обмежується виключно видачею відповідного свідоцтва встановленого зразка.

В. Враховує стадії переживання горя та допомогу в оформленні статусів і виплат.

Г. Не має жодних відмінностей від супроводу демобілізованих ветеранів.

46. Як ветеран може реалізувати право на безоплатну психологічну допомогу?

А. Звернувшись до приймального відділення будь-якої багатопрофільної лікарні.

Б. Виключно через приватні медичні клініки за власні кошти.

В. Цим правом можуть скористатися тільки діючі військовослужбовці.

Г. Звернувшись до закладів, законтракованих НСЗУ/Мінветеранів.

47. Який Закон України визначає основні пільги та гарантії для ветеранів війни?

А. Закон України «Про соціальні послуги».

Б. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

В. Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу».

Г. Кодекс цивільного захисту України.

48. Який підхід є найбільш коректним у спілкуванні з членами сімей загиблих Захисників і Захисниць?

А. Підтримувати розмову лише в межах практичних питань, щоб не торкатися болісних переживань родини.

Б. Звертати увагу на емоційний стан родини та за потреби рекомендувати психологічну допомогу як основний напрям підтримки.

В. Тактовно визнавати значущість втрати, уважно слухати, уникати знецінювальних фраз і враховувати готовність родини говорити про загиблого.

Г. Допомогати родині зосередитися на оформленні статусів і виплат, поступово переводячи увагу з переживання втрати на практичні дії.

49. Який метод тайм-менеджменту найдоцільніше використовувати для планування робочого дня?

А. Виконання завдань у послідовності їх надходження, незалежно від строків виконання.

Б. Використання матриці Ейзенхауера.

В. Спершу виконати простіші поточні доручення, а потім перейти до більш складних завдань.

Г. Одночасне виконання кількох складних завдань для економії часу та швидшого завершення запланованого обсягу роботи.

50. Яке визначення найточніше розкриває зміст поняття «активне слухання»?

А. Комунікативна техніка, що передбачає зосереджену увагу до співрозмовника, уточнювальні запитання, емпатійне реагування та перевірку правильності розуміння сказаного.

Б. Уважне вислуховування співрозмовника з періодичним доповненням його думок власними оцінками, порадами або прикладами з професійного досвіду.

В. Мовчазне сприйняття інформації без уточнень і зворотного зв'язку, щоб не переривати хід думок співрозмовника.

Г. Слухання основного змісту розмови з одночасним виконанням нескладних службових завдань, якщо це не заважає загальному розумінню ситуації.

Термін виконання – 90 хвилин

Контрольно-оцінювальні матеріали (тестові завдання) варіант 2

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Що є основним національним стандартом для оформлення службових документів в Україні?

- А. ДСТУ 2732:2004 «Діловодство й архівна справа».
- Б. ISO 9001 «Системи управління якістю».
- В. ДСТУ 4163:2020.
- Г. ДСТУ 3008:2015 «Звіти у сфері науки і техніки».

2. Що з наведеного належить до правил ділового мережевого етикету при електронному листуванні?

- А. Використання виключно великих літер (CAPS LOCK) для виділення важливих думок.
- Б. Обов'язкове заповнення поля «Тема» та наявність підпису з контактними даними.
- В. Відправка службових листів у будь-який час доби, включаючи нічні години.
- Г. Використання неформального сленгу та емодзі.

3. Який метод тайм-менеджменту найдоцільніше використовувати для планування робочого дня?

- А. Виконання завдань у послідовності їх надходження, незалежно від строків виконання.
- Б. Використання матриці Ейзенхауера.
- В. Спершу виконати простіші поточні доручення, а потім перейти до більш складних завдань.
- Г. Одночасне виконання кількох складних завдань для економії часу та швидшого завершення запланованого обсягу роботи.

4. Яка основна мета моніторингу у процесі індивідуального супроводу ветерана?

- А. Регулярно відстежувати зміни в ситуації ветерана, оцінювати досягнення визначених цілей і за потреби коригувати індивідуальний план супроводу.
- Б. Накопичувати статистичні дані для звітності органів державної влади без обов'язкового впливу на подальші дії фахівця.
- В. Виявляти формальні підстави для скорочення або припинення супроводу, якщо ветеран не демонструє швидкого прогресу.
- Г. Оцінювати якість роботи медичних, освітніх та соціальних установ замість аналізу потреб і динаміки стану самого ветерана.

5. Зазначте вірний порядок реалізації програмно-цільового методу формування місцевих бюджетів:

- А. Визначення проблем; планування заходів; впровадження заходів; моніторинг результатів; аналіз досягнутої мети.
- Б. Визначення проблем; впровадження заходів без попереднього планування.
- В. Розрахунок залишків коштів; впровадження заходів; моніторинг результатів; аналіз досягнутої мети.
- Г. Розрахунок залишків коштів; визначення проблем; планування заходів; впровадження заходів.

6. Яким цифровим інструментом ветеран може скористатися для доступу до власних даних?

- А. Тільки шляхом подання письмового запиту на поштову адресу відомства.
- Б. Виключно через офіційний веб-портал Верховної Ради України.
- В. Через мобільний застосунок та портал Дія.
- Г. Через електронну пошту районної державної адміністрації.

7. Яке визначення найточніше розкриває зміст поняття «активне слухання»?

А. Комунікативна техніка, що передбачає зосереджену увагу до співрозмовника, уточнювальні запитання, емпатійне реагування та перевірку правильності розуміння сказаного.

Б. Уважне вислуховування співрозмовника з періодичним доповненням його думок власними оцінками, порадами або прикладами з професійного досвіду.

В. Мовчазне сприйняття інформації без уточнень і зворотного зв'язку, щоб не переривати хід думок співрозмовника.

Г. Слухання основного змісту розмови з одночасним виконанням нескладних службових завдань, якщо це не заважає загальному розумінню ситуації.

8. Яка основна мета первинної зустрічі фахівця з ветераном у процесі подальшого супроводу?

А. Спробувати одразу надати рішення щодо більшості запитів ветерана, щоб зменшити потребу в наступних консультаціях.

Б. Провести поглиблене опрацювання психологічного досвіду ветерана та визначити приховані причини його актуальних труднощів.

В. Встановити довірливий контакт, зібрати первинну інформацію про ситуацію ветерана, уточнити його запити та попередньо визначити потреби.

Г. Спочатку підготувати необхідні документи для отримання всіх доступних державних пільг і соціальних гарантій.

9. Який підхід є найбільш коректним у спілкуванні з членами сімей загиблих Захисників і Захисниць?

А. Підтримувати розмову лише в межах практичних питань, щоб не торкатися болісних переживань родини.

Б. Звертати увагу на емоційний стан родини та за потреби рекомендувати психологічну допомогу як основний напрям підтримки.

В. Тактовно визнавати значущість втрати, уважно слухати, уникати знецінювальних фраз і враховувати готовність родини говорити про загиблого.

Г. Допомогати родині зосередитися на оформленні статусів і виплат, поступово переводячи увагу з переживання втрати на практичні дії.

10. Який Закон України визначає основні пільги та гарантії для ветеранів війни?

А. Закон України «Про соціальні послуги».

Б. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

В. Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу».

Г. Кодекс цивільного захисту України.

11. Яка знижка на оплату житлово-комунальних послуг передбачена для осіб з інвалідністю внаслідок війни?

А. 100%.

Б. 75% від встановленого тарифу на послуги.

В. 50% від встановленого тарифу на послуги.

Г. Знижка на оплату комунальних послуг не передбачена.

12. Що означає «перехід від військової служби до цивільного життя»?

А. Процес безпосереднього звільнення військовослужбовця в запас.

Б. Система заходів для успішної адаптації звільненого військовослужбовця.

В. Процедура отримання посвідчення учасника бойових дій (УБД).

Г. Офіційна зміна військового звання на цивільну спеціальність.

13. Як ветеран може реалізувати право на безоплатну психологічну допомогу?

А. Звернувшись до приймального відділення будь-якої багатопрофільної лікарні.

Б. Виключно через приватні медичні клініки за власні кошти.

В. Цим правом можуть скористатися тільки діючі військовослужбовці.

Г. Звернувшись до закладів, законтракованих НСЗУ/Мінветеранів.

14. Що є основою методології кейс-менеджменту під час супроводу ветерана?

А. Надання ветерану окремої консультації або допомоги з отриманням конкретної довідки.
Б. Індивідуальний підхід, комплексна оцінка потреб, розроблення індивідуального плану супроводу, координація послуг і подальший моніторинг результатів.

В. Спрямування ветерана до інших установ після первинного звернення, якщо його запит виходить за межі повноважень одного фахівця.

Г. Ведення необхідної документації та заповнення звітних форм як основний спосіб підтвердження надання супроводу.

15. З чого починається процес кейс-менеджменту у роботі з ветераном?

А. Із завершення попереднього супроводу та формального закриття справи після первинного звернення ветерана.

Б. Із визначення можливості надання матеріальної або фінансової допомоги як першого етапу роботи.

В. З первинного контакту, оцінки потреб ветерана, отримання згоди на супровід і подальшого розроблення індивідуального плану.

Г. З направлення ветерана до медичного закладу незалежно від характеру його першочергового запиту.

16. Що робити, якщо проблема виходить за межі компетенції фахівця?

А. Спробувати вирішити проблему самостійно з метою збереження авторитету.

Б. Ігнорувати проблему та зосередитися на інших завданнях.

В. Маршрутизувати до профільного спеціаліста (юрист, психотерапевт, лікар).

Г. Порадити ветерану звернутися по допомогу до родичів чи друзів.

17. Яка мета взаємодії фахівця з центрами зайнятості?

А. Отримання персональної інформації про керівництво центру зайнятості.

Б. Координація зусиль для профорієнтації, перенавчання та працевлаштування ветерана.

В. Повна передача функцій центрів зайнятості фахівцям із супроводу.

Г. Контроль за виплатою ветераном податків від підприємницької діяльності.

18. Чим відрізняється супровід членів сім'ї загиблого Захисника?

А. Не потребує складання індивідуального плану супроводу.

Б. Обмежується виключно видачею відповідного свідоцтва встановленого зразка.

В. Враховує стадії переживання горя та допомогу в оформленні статусів і виплат.

Г. Не має жодних відмінностей від супроводу демобілізованих ветеранів.

19. Профорієнтація ветеранів – це:

А. Комплекс заходів для обрання цивільної професії відповідно до здібностей та ринку праці.

Б. Призначення на військові посади.

В. Направлення на роботу.

Г. Тестування професійної підготовки.

20. Яку можливість надає «ваучер на навчання»?

А. Безоплатну перепідготовку або підвищення кваліфікації.

Б. Отримання суттєвої знижки на придбання споживчих товарів.

В. Безкоштовні квитки на всі види громадського та міжміського транспорту.

Г. Звільнення від складання вступних іспитів до будь-якого ЗВО.

21. На що доцільно спиратися під час складання цивільного резюме ветерана?

А. На мінімізацію будь-яких згадок про військовий досвід, щоб уникнути додаткових запитань з боку роботодавця.

Б. На доповнення резюме узагальненими формулюваннями про цивільний досвід, навіть якщо він не підтверджується реальними професійними ситуаціями.

В. На адаптацію військового досвіду, управлінських, комунікаційних і лідерських навичок до мови цивільних компетентностей, зрозумілих роботодавцю.

Г. На детальний опис військових посад, підрозділів, спеціалізованих аббревіатур і службових процедур без пояснення їхнього практичного значення для цивільної роботи.

22. Що передбачає психологічна складова адаптації ветерана до цивільного життя?

А. Переважне застосування медикаментозного лікування як основного способу вирішення труднощів адаптації незалежно від індивідуальних потреб ветерана.

Б. Обов'язкове проведення поглибленого психіатричного оцінювання для всіх ветеранів перед початком соціальної або професійної адаптації.

В. Підтримку в усвідомленні змін життєвої ролі й статусу, опрацюванні наслідків бойового стресу, відновленні стосунків та пошуку особистих ресурсів.

Г. Тимчасове обмеження соціальних контактів ветерана, щоб зменшити вплив зовнішніх чинників на процес його психологічного відновлення.

23. Що означає принцип «зворотного зв'язку» у процесі супроводу ветерана?

А. Використання оперативних каналів зв'язку між фахівцями для передавання службової інформації щодо організації роботи.

Б. Можливість ветерана висловити оцінку, зауваження або пропозиції щодо якості, доступності та корисності отриманих послуг.

В. Повернення ветерану коштів або ресурсів у разі, якщо окремі заходи супроводу не дали очікуваного результату.

Г. Надсилання формальної відповіді на звернення ветерана після завершення адміністративного розгляду його питання.

24. Чому важливо документувати результати моніторингу в процесі супроводу ветерана?

А. Щоб зафіксувати додаткові вимоги до ветерана та посилити контроль за виконанням ним рекомендацій фахівця.

Б. Щоб забезпечити безперервність супроводу, обґрунтовано коригувати план роботи, здійснювати звітність і аналізувати ефективність наданої підтримки.

В. Щоб надалі використовувати історію ветерана як приклад для інформаційних матеріалів без необхідності додаткового погодження.

Г. Щоб замінити безпосереднє спілкування з ветераном письмовими записами про перебіг супроводу та ухвалені рішення.

25. Які принципи професійної етики є обов'язковими для фахівця, який здійснює супровід ветеранів?

А. Дотримання конфіденційності, повага до гідності та автономії ветерана, неупередженість, толерантність, професійна відповідальність і збереження меж компетентності.

Б. Надання підтримки з урахуванням особистого ставлення фахівця до рішень ветерана, за умови що це не перешкоджає досягненню формальних цілей супроводу.

В. Використання інформації про життєвий досвід ветерана для міжвідомчої взаємодії, професійного навчання або публічного інформування без окремого погодження.

Г. Пріоритетне ухвалення рішень фахівцем у складних випадках.

26. Для чого фахівцю необхідна професійна рефлексія у процесі супроводу ветеранів?

А. Щоб аналізувати складні випадки, зіставляти їх із посадовими вимогами та визначати, які дії були виконані відповідно до алгоритму.

Б. Щоб осмислювати власні дії, емоційні реакції й професійні рішення, своєчасно помічати ризики та підвищувати якість супроводу.

В. Щоб узагальнювати досвід роботи з ветеранами, описувати типові ситуації та використовувати їх для професійного обміну з колегами.

Г. Щоб оцінювати перебіг супроводу, визначати зовнішні труднощі в роботі та враховувати їх під час подальшого планування.

27. До психологічних послуг, які суб'єкт надання послуг зобов'язується надавати за державні кошти, відносяться (відповідно до індивідуальних потреб отримувача послуг):

А. Проведення первинного психодіагностичного обстеження членами мультидисциплінарної команди.

Б. Визначення психологічного стану або психічного розладу, рівня психосоціальної дезадаптації.

В. Визначення реабілітаційного прогнозу мультидисциплінарною командою за результатами психодіагностичного обстеження.

Г. Усі відповіді вірні.

28. Яка характеристика найбільш точно відображає особливість кризового консультування?

А. Надання людині можливості безпечно висловити емоції, зниження гостроти напруження та підтримка доступних внутрішніх і зовнішніх ресурсів.

Б. Детальний аналіз глибинних причин виникнення кризової ситуації як основний фокус первинної допомоги.

В. Проведення психологічного дебрифінгу як стандартного етапу роботи з кожною людиною, яка пережила кризову подію.

Г. Зміщення уваги з кризової події на довгострокове планування майбутнього для швидшого повернення до звичного функціонування.

29. Який варіант найповніше відображає принципи медіації?

А. Добровільність участі сторін та повна конфіденційність процесу.

Б. Нейтральність, незалежність та неупередженість професійного медіатора.

В. Самовизначення сторін конфлікту та повна рівність їхніх прав у процесі.

Г. Добровільність, конфіденційність, нейтральність, незалежність та неупередженість медіатора, самовизначення та рівність прав сторін медіації.

30. Які дії має здійснити фахівець при отриманні усного звернення від ветерана на особистому прийомі?

А. Зафіксувати звернення в журналі обліку та/або ввести в електронну базу.

Б. Надати роз'яснення усно, не реєструючи факт звернення для оптимізації обліку.

В. Рекомендувати ветерану звернутися письмово через поштове відділення.

Г. Передати вирішення питання до юридичного відділу.

31. Що є грубим порушенням правил обробки персональних даних?

А. Збір та накопичення персональних даних у мінімально необхідному обсязі.

Б. Ознайомлення суб'єкта персональних даних з його правами під підпис.

В. Знищення персональних даних після закінчення встановленого терміну їх зберігання.

Г. Передача контактних та персональних даних ветерана третім особам без його згоди.

32. Які заходи з інформаційної безпеки повинен щоденно застосовувати фахівець?

А. Застосовувати спільний для робочої групи пароль доступу для прискорення обміну службовою інформацією.

Б. Тимчасово передавати автентифікаційні дані іншим співробітникам центру у разі виробничої необхідності.

В. Блокувати екран комп'ютера при відході від робочого місця.

Г. Зберігати файли з даними на особистій флешці.

33. Яка поведінка фахівця є найбільш професійною, якщо ветеран під час спілкування демонструє виражене роздратування або гнів?

А. Продемонструвати контроль над ситуацією, щоб не допустити подальшого загострення розмови.

- Б. Завершити розмову одразу після прояву гніву.
- В. Зберігати спокій, говорити рівним тоном та застосовувати техніки деескалації.
- Г. Зосередитися на з'ясуванні причин роздратування та спробувати обговорити ситуацію, що склалася.

34. Суїцидальна поведінка, пов'язана з кризовими ситуаціями в житті і особистісними трагедіями, називається:

- А. Психогенною.
- Б. Дистимічною.
- В. Альтруїстичною.
- Г. Егоїстичною.

35. Який варіант найповніше розкриває завдання інтегрованого підходу у роботі з ветеранами?

- А. Комплексна соціальна реінтеграція та координація міжвідомчої допомоги.
- Б. Надання одноразової фінансової допомоги.
- В. Організація реабілітаційних заходів.
- Г. Проведення медичного обстеження.

36. Яка обов'язкова умова для обробки персональних даних ветерана?

- А. Отримання письмової або електронної згоди ветерана.
- Б. Наявність у ветерана посвідчення УБД.
- В. Усна згода родичів ветерана.
- Г. Дозвіл керівника установи.

37. Які особи належать до категорії «ветерани війни»?

- А. Лише військовослужбовці, які проходять службу в Збройних Силах України.
- Б. Особи, які проходили строкову службу в лавах армії в мирний час.
- В. Усі громадяни України, які проживали в зоні ведення бойових дій.
- Г. Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни.

38. Де ветеран може отримати послугу через сервіс «Я – ветеран»?

- А. У Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).
- Б. Виключно безпосередньо у департаменті Міністерства у справах ветеранів.
- В. У територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
- Г. У відділеннях Національної поліції України за місцем перебування.

39. Що може бути бар'єром для соціальної адаптації ветерана?

А. Наявність підтримувального соціального оточення, базової фінансової стабільності та готовності ветерана поступово відновлювати участь у житті громади.

Б. Доступ до програм перекваліфікації, інформованість про соціальні гарантії та можливість отримувати консультативну підтримку від профільних фахівців.

В. Попередній досвід відповідальності, командної взаємодії та прийняття рішень у складних умовах, який може бути адаптований до цивільної професійної сфери.

Г. Обмеженість соціальних контактів, труднощі з переосмисленням військового досвіду в цивільному середовищі, невідповідність наявних навичок вимогам ринку праці та наслідки травматичного досвіду.

40. Якщо ветеран хоче відкрити справу, що має зробити фахівець?

- А. Рекомендувати відмовитись від бізнес-ініціативи враховуючи можливі ризики.
- Б. Запропонувати залучення власних фінансових ресурсів фахівця.
- В. Розробити та написати детальний бізнес-план підприємства разом з ветераном.
- Г. Проінформувати про грантові програми (є-Робота), допомогти знайти курси.

41. З якою періодичністю здійснюється моніторинг плану супроводу?

- А. Тільки після повного завершення всіх запланованих заходів.
- Б. Регулярно, згідно з графіком, узгодженим з ветераном.

- В. Один раз на п'ять років у межах загальної інспекції.
- Г. Виключно у разі надходження офіційної скарги від ветерана.

42. Професійне вигорання – це:

- А. Стан фізичного, емоційного та розумового виснаження від тривалого стресу.
- Б. Тимчасова втома після напруженого робочого дня.
- В. Бажання підвищити професійну кваліфікацію.
- Г. Процес запланованої зміни професії чи напрямку діяльності.

43. Який інструмент найефективніший для профілактики вигорання?

- А. Уникнення спілкування з клієнтами та ігнорування їхніх запитів.
- Б. Регулярна участь у супервізійних групах, баланс роботи та життя.
- В. Збільшення робочого навантаження для відволікання від стресу.
- Г. Відпустка, відпочинок у вихідні дні.

44. Яка дія фахівця є найбільш етично обгрунтованою, якщо його особисті переконання не збігаються з рішенням ветерана?

- А. Коректно висловити ветерану власне бачення ситуації та поступово спрямовувати його до рішення, яке фахівець вважає більш правильним.
- Б. Надати ветерану критичний зворотний зв'язок щодо його рішення, щоб допомогти йому усвідомити можливі помилки у власній позиції.
- В. Зберігати професійну неупередженість, поважати автономію ветерана, діяти в межах його законних інтересів.
- Г. Обмежити подальшу взаємодію темами, які не викликають внутрішнього конфлікту у фахівця, щоб уникнути впливу особистих переконань на супровід.

45. Яка професійна підтримка потрібна ветеранам на перших етапах адаптації?

- А. Навчання новим професійним навичкам та кар'єрне консультування.
- Б. Надання психотерапевтичної допомоги.
- В. Разова виплата матеріальної допомоги.
- Г. Контроль за дотриманням розпорядку дня.

46. Індивідуальна паніка як тип психічної реакції під час бойових дій не включає:

- А. Неконтрольований плач.
- Б. Кататонічний ступор.
- В. Безладний біг колами.
- Г. Безрозсудні спроби втечі.

47. Бойові стресові розлади за етіопатогенетичним шляхом належать до:

- А. Психогенних розладів.
- Б. Ендогенних захворювань.
- В. Соціогенних реакцій.
- Г. Невротичних розладів розвитку.

48. Які ознаки загального адаптаційного синдрому є зайвими:

- А. Стадія психозу.
- Б. Стадія тривоги.
- В. Стадія резистентності.
- Г. Стадія виснаження.

49. Ветеранське підприємництво – це:

- А. Створення власної справи ветеранами з урахуванням їх специфічних потреб та лідерського досвіду.
- Б. Організація бізнесу за кошти державних дотацій.
- В. Працевлаштування ветеранів у державні установи на керівні посади.
- Г. Співпраця з міжнародними оборонними компаніями.

50. Яка роль кейс-менеджера у процесі планування?

- А. Координація надання послуг та взаємодія з партнерами в інтересах клієнта.
- Б. Пасивне спостереження за діями клієнта.
- В. Надання професійної юридичної та адвокатської допомоги.
- Г. Навчання клієнта новим виробничим та професійним навичкам.

Термін виконання – 90 хвилин

Комплексне кваліфікаційне (практичне) завдання №1

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Захист персональних даних та робота з агресивним клієнтом

Опис ситуації:

До фахівця звернувся ветеран Д. із проханням допомогти дізнатися статус заяви на отримання житлової пільги, яку подавав його побратим С. С. зараз перебуває у шпиталі в іншій області й не має зв'язку, але йому терміново потрібна ця інформація. Д. має копію паспорта С. у своєму телефоні, але не має довіреності. Д. поводить роздратовано і звинувачує фахівця у бюрократії.

Питання: Яка послідовність дій фахівця є найбільш професійною та відповідає чинному законодавству?

1. Фахівець має врахувати критичність ситуації, копію паспорта С. та пояснення Д. про те, що він діє в інтересах побратима. Доцільно зареєструвати усне звернення Д., перевірити статус заяви в базі даних і надати йому стислу інформацію без зайвих деталей, оскільки затримка може погіршити становище С.

2. Фахівець має висловити підтримку Д., спокійно пояснити, що копія паспорта не підтверджує права представляти іншу особу, а персональні дані не можуть бути розголошені без згоди С. або належного представництва. Водночас фахівець має запропонувати законні шляхи: зв'язок із С. через соціального працівника чи адміністрацію шпиталю, отримання згоди у визначений процедурою спосіб або оформлення довіреності.

3. Фахівець має послатися на вимоги законодавства щодо захисту персональних даних і відмовити Д. у наданні інформації про заяву С. Оскільки Д. не має довіреності, подальші дії з його боку неможливі, тому фахівець має порадити С. звернутися особисто після відновлення зв'язку або після виписки зі шпиталю.

4. Фахівець має прийняти звернення Д., зафіксувати його прохання та самостійно зв'язатися з установою, де розглядається заява С. Після отримання інформації доцільно повідомити Д. лише загальний статус заяви без деталізації персональних даних, а також порадити йому надалі оформити довіреність або отримати письмову згоду С.

2. Перша психологічна допомога при гострій реакції на стрес

Опис ситуації:

Під час первинної зустрічі ветеран О., який нещодавно демобілізувався, виглядає дуже напруженим. Він уникає зорового контакту, говорить уривчастими фразами, його руки помітно тремтять. Коли повз офіс гучно проїжджає вантажівка, О. різко здригається, хапається за стіл і застигає, важко дихаючи.

Питання: Яка послідовність дій є найбільш правильною з боку фахівця в цей момент?

1. Фахівець має швидко підійти до О., покласти руку йому на плече або обійняти, щоб продемонструвати підтримку та допомогти відчути безпеку. Після цього слід покликати колег, запропонувати О. присісти зручніше та пояснити, що реакція вже минула і небезпеки немає.

2. Фахівець має залишатися поруч на безпечній відстані, спокійним голосом звернутися до О. на ім'я та допомогти йому зорієнтуватися в теперішньому моменті. Доцільно запропонувати разом зробити повільний вдих і видих, назвати кілька предметів у кімнаті та дочекатися стабілізації дихання, не торкаючись О. без його згоди.

3. Фахівець має не привертати зайвої уваги до реакції О., щоб не посилити його напруження або сором. Доцільно продовжити заповнення анкети первинного виявлення потреб, говорити звичним тоном, запропонувати воду чи каву та повернутися до обговорення стану О. наприкінці зустрічі.

4. Фахівець має негайно викликати швидку медичну допомогу, повідомити О., що в нього, ймовірно, панічна атака або прояв ПТСР, та попросити колег допомогти зафіксувати його стан до приїзду медиків. Після цього слід відкласти подальшу розмову до отримання медичного висновку.

3. Захист прав ветеранів на міжміські перевезення

Опис ситуації:

Ветеранка Т., яка отримала поранення та звільнилася зі служби зі статусом особи з інвалідністю внаслідок війни II групи, звернулася з проблемою: водій міжміського автобуса відмовив їй у безкоштовному проїзді, мотивуючи це тим, що ліміт пільгових місць (який начебто встановлений перевізником) на цей рейс уже вичерпано. Т. обурена та хоче подати до суду на автопарк.

Питання: Що є найбільш конструктивним алгоритмом дій фахівця з супроводу?

1. Фахівець має допомогти Т. зафіксувати обставини інциденту: дату, час, маршрут, номер рейсу, державний номер автобуса, назву перевізника, за можливості – ПІБ водія, фото, відео або контакти свідків. Після цього слід допомогти скласти скаргу до Укртрансбезпеки та органу, який є замовником перевезень, роз'яснивши, що встановлення перевізником «ліміту пільгових місць» не може скасовувати право на пільговий проїзд, передбачене законом.

2. Фахівець має пояснити Т., що приватні перевізники можуть встановлювати внутрішні правила щодо кількості пільгових місць, якщо це передбачено умовами перевезення. Доцільно запропонувати їй не загострювати конфлікт, зберегти квиток або інші підтвердження поїздки та звернутися по компенсацію вартості проїзду до місцевої програми підтримки ветеранів або благодійної організації.

3. Фахівець має порадити Т. спочатку звернутися безпосередньо до адміністрації автотранспортного підприємства із письмовою претензією та вимогою надати пояснення щодо відмови. Якщо перевізник не відповість або відмовиться визнавати порушення, фахівець може допомогти підготувати повторне звернення до перевізника, а питання звернення до контролюючих органів або суду розглянути лише після отримання офіційної відповіді.

4. Фахівець має порадити Т. надалі заздалегідь уточнювати у перевізника наявність пільгових місць на конкретний рейс і, за можливості, обирати іншого перевізника. У цій ситуації доцільно не витрачати час на скарги, а звернутися до місцевої ради або благодійної організації для відшкодування вартості проїзду.

4. Робота з кризовими сім'ями та етичні дилеми підпису документів

Опис ситуації:

Фахівець здійснює супровід сім'ї загиблого Захисника (дружину О. та двох дітей). О. перебуває у стані глибокої апатії, пов'язаної з переживанням втрати, не виходить з дому і не може змусити себе зайнятися документами на отримання одноразової грошової допомоги. Термін подачі документів спливає. Двоюрідна сестра О. просить фахівця передати їй бланки заяв, обіцяючи підписати їх замість О., щоб родина не втратила гроші.

Питання: Як має вчинити фахівець у межах кейс-менеджменту?

1. Фахівець має врахувати інтереси дітей і терміновість ситуації, тому може передати бланки сестрі О. для оперативного оформлення документів. Якщо О. тимчасово не здатна займатися цим особисто, сестра може підписати заяви замість неї, а фахівець має додати пояснення про складний психологічний стан клієнтки та необхідність збереження права сім'ї на допомогу.

2. Фахівець має повідомити орган опіки та піклування про те, що О. через свій психологічний стан не забезпечує належного оформлення документів в інтересах дітей. Після цього доцільно передати сестрі інформацію про подальший порядок дій, а оформлення заяв

відкласти до моменту, коли буде визначено особу, яка тимчасово представлятиме інтереси дітей і сім'ї.

3. Фахівець має узгодити з О. можливість домашнього візиту, за потреби – разом із сестрою як підтримувальною особою. Під час зустрічі слід тактовно висловити підтримку, пояснити значення дотримання термінів, допомогти О. особисто заповнити й підписати документи. Якщо її стан суттєво ускладнює прийняття рішень, необхідно ініціювати термінове залучення психолога, мобільної бригади соціально-психологічної допомоги або іншого уповноваженого фахівця.

4. Фахівець має передати сестрі О. перелік необхідних документів і дозволити їй допомогти із заповненням заяв, якщо це пришвидшить процес. Підпис О. можна отримати пізніше, коли її стан покращиться, а зараз важливо не втратити строк подання документів на допомогу.

Кейс 5. Кар'єрна адаптація ветеранів з інвалідністю

Опис ситуації:

Ветеран І. до служби працював автомеханіком. Внаслідок поранення він отримав ампутацію лівої руки нижче ліктя і більше не може виконувати колишню фізичну роботу. І. пригнічений, вважає себе «непридатним ні до чого», категорично відмовляється від пропозицій перенавчання на IT-спеціальності, зазначаючи, що «офісна робота – це не його», і він хоче працювати тільки в автосфері.

Питання: Яка стратегія профорієнтації з боку фахівця є найбільш ефективною та етичною?

1. Фахівець має пояснити І., що повернення до попередньої роботи автомеханіком є малоймовірним, тому варто зосередитися на професіях, які не потребують фізичного навантаження. Доцільно запропонувати йому курси програмування, тестування програмного забезпечення або інші дистанційні напрями, які мають попит на ринку праці.

2. Фахівець має допомогти І. розглянути вакансії з мінімальним фізичним навантаженням і невисокими вимогами до професійної підготовки. Можна запропонувати посади диспетчера, чергового, адміністратора або консультанта, щоб ветеран швидше повернувся до зайнятості й поступово адаптувався до нових умов.

3. Фахівець має проаналізувати попередній досвід, знання й сильні сторони І. в автосфері та разом із ним визначити суміжні професійні ролі. Доцільно розглянути посади майстра-приймальника на СТО, менеджера з підбору автозапчастин, консультанта з технічних питань або оцінювача пошкоджень авто, а також підібрати короткі курси для переходу на ці позиції.

4. Фахівець має запропонувати І. тимчасово не повертатися до професійної діяльності, оскільки після ампутації йому спочатку потрібно повністю прийняти новий стан. Питання працевлаштування доцільно відкласти до завершення психологічної адаптації та медичної реабілітації.

Кейс 6. Консультування щодо ветеранського бізнесу та межі повноважень

Опис ситуації:

Ветеран С. планує відкрити невелику ветеринарну клініку. Він дізнався від побратимів про державну програму грантів для ветеранів на створення власного бізнесу. С. приходить до фахівця Центру та вимагає, щоб той написав замість нього бізнес-план та подав заявку через Дію, аргументуючи це тим, що він «воював, поки інші вчилися писати бізнес-плани, і не розуміє цих фінансових таблиць».

Питання: Яка роль та алгоритм дій фахівця із супроводу в цій ситуації?

1. Фахівець має роз'яснити С. умови грантової програми, надати інструкцію щодо структури заявки та допомогти розібратися з основними розділами бізнес-плану. Доцільно спрямувати його

на безоплатні бізнес-курси для ветеранів, організувати консультацію з ментором або фахівцем із фінансових розрахунків, зберігаючи за С. роль автора і заявника проекту.

2. Фахівець має врахувати складність ситуації для С. і допомогти йому максимально практично: самостійно підготувати бізнес-план на основі його усних пояснень, заповнити фінансові таблиці та супроводити подання заявки через Дію. Це дасть змогу зменшити бар'єри для ветерана та підвищити його шанси на участь у грантовій програмі.

3. Фахівець має пояснити С., що написання бізнес-планів і фінансових розрахунків не належить до його посадових обов'язків. Доцільно надати загальне посилення на умови грантової програми та порекомендувати звернутися до бізнес-консультанта, бухгалтера або комерційної організації, яка професійно готує такі заявки.

4. Фахівець має порадити С. звернутися до побратимів, які вже отримували гранти, і використати їхній бізнес-план як основу для власної заявки. Це допоможе швидше підготувати документи та зменшить навантаження на фахівця Центру.

7. Коригування індивідуального плану супроводу

Опис ситуації:

Ветеран А. проходить супровід у Центрі. Згідно з його індивідуальним планом, пріоритетами були санаторно-курортне лікування для відновлення опорно-рухового апарату та подальше працевлаштування. Під час моніторингового дзвінка фахівець дізнається, що А. відмовився від путівки в санаторій, оскільки «не хоче нікуди їхати», і не з'явився на жодну з трьох співбесід, організованих Центром зайнятості. А. каже, що «все це марно і нікому він не потрібен».

Питання: Які подальші дії фахівця в межах моніторингу та оцінювання потреб А.?

1. Фахівець має зафіксувати невиконання окремих пунктів індивідуального плану та провести з А. роз'яснювальну бесіду щодо можливих наслідків відмови від запропонованих заходів. Після цього доцільно тимчасово призупинити активний супровід, залишивши за А. можливість повторно звернутися до Центру, коли він буде готовий виконувати погоджений план.

2. Фахівець має організувати особисту зустріч у безпечному й комфортному для А. форматі, обговорити причини відмови від санаторію та співбесід, повторно оцінити його актуальний психологічний стан, мотивацію й потреби. За результатами оцінки слід скоригувати індивідуальний план: наприклад, тимчасово відтермінувати працевлаштування, посилити психологічну підтримку та запропонувати залучення до ветеранської спільноти.

3. Фахівець має зв'язатися з близькими родичами А., поінформувати їх про невиконання ним індивідуального плану та попросити підтримати його у відновленні активності. Доцільно разом із родиною домовитися про додатковий контроль за відвідуванням співбесід і поїздкою до санаторію, щоб допомогти А. повернутися до попередньо визначених цілей.

4. Фахівець має залишити індивідуальний план без змін, оскільки він уже був погоджений із ветераном. Доцільно нагадати А. про взяті зобов'язання та встановити нові строки виконання тих самих заходів без повторного оцінювання потреб.

8. Запобігання конфлікту інтересів

Опис ситуації:

До фахівця із супроводу звернувся його близький товариш та колишній однокласник М., який повернувся з зони бойових дій. М. просить допомогти йому отримати матеріальну допомогу на лікування з місцевого бюджету позачергово, оскільки має великі борги. Фахівець знає, що черга на цю допомогу є великою, кошти обмежені, а інші ветерани чекають рішення комісії по 2-3 місяці. М. просить «по-дружньому» прискорити розгляд та поставити його заяву першою.

Питання: Які дії фахівця відповідають стандартам професійної етики?

1. Фахівець має пояснити М., що їхні особисті стосунки створюють конфлікт інтересів, тому позачергове просування заяви є неприпустимим. Водночас він може надати інформацію про загальний порядок отримання допомоги, допомогти підготувати документи відповідно до вимог і запропонувати передати супровід справи іншому фахівцю для забезпечення прозорості та неупередженості.

2. Фахівець має врахувати складну життєву ситуацію М. та надати йому практичну підтримку в межах наявних можливостей. Доцільно допомогти швидко підготувати документи, звернутися до відповідальних осіб щодо термінового розгляду заяви та обґрунтувати пріоритетність випадку станом здоров'я й фінансовими обставинами М.

3. Фахівець має прийняти документи М. у загальному порядку, але не повідомляти колегам про особисте знайомство, якщо це не впливає на формальну процедуру розгляду. Щоб уникнути відкритого конфлікту, він може вести справу самостійно, не змінюючи місце заяви в черзі та не надаючи М. додаткових переваг.

4. Фахівець має відмовитися від будь-якої участі в ситуації, оскільки звернення М. містить прохання про особисте сприяння. Доцільно повідомити М., що він має самостійно звернутися до Центру в загальному порядку, а фахівець надалі не повинен надавати йому консультацій, щоб уникнути звинувачень у необ'єктивності.

9. Профілактика професійного вигорання та саморегуляція

Опис ситуації:

Фахівець працює із ветеранами вже понад півтора року. Останні кілька місяців він відчуває хронічну втому, яка не минає після вихідних, та часті головні болі. Історії клієнтів почали викликати у нього байдужість, а іноді – роздратування. Під час обговорення важкого кейсу колеги він цинічно зауважив: «Вони самі знали, куди йшли, нема чого тепер скаржитися». Раніше фахівець ніколи не дозволяв собі подібного.

Питання: Що має зробити фахівець у цій ситуації для відновлення своєї професійної придатності?

1. Фахівець має розцінити свій стан як звичайну втому, що може виникати під час інтенсивної роботи з людьми. Доцільно тимчасово зосередитися на виконанні службових обов'язків, не обговорювати емоційні реакції з колегами та спробувати відновити самоконтроль через дисципліну й збільшення професійної залученості.

2. Фахівець має визнати втрату емпатії ознакою серйозного професійного виснаження та зробити висновок, що подальша робота з ветеранами для нього є небажаною. Доцільно звернутися до керівництва із заявою про переведення на іншу посаду або звільнення, щоб не допустити погіршення якості супроводу клієнтів.

3. Фахівець має визнати наявність ознак професійного виснаження та звернутися до керівництва щодо позачергової індивідуальної супервізії. Доцільно переглянути робоче навантаження, використати відпустку або інший ресурс для відновлення, обговорити з супервізором професійні межі та долучитися до навчання чи заходів із профілактики емоційного вигорання.

4. Фахівець має самостійно вжити заходів для швидкого зниження напруження, щоб не переривати роботу з клієнтами. Доцільно скористатися порадами колег щодо заспокійливих засобів, обмежити участь у складних обговореннях кейсів і повернутися до питання професійного відновлення після завершення найбільш напруженого періоду.

10. Домашнє насильство та робота з родиною ветерана

Опис ситуації:

До фахівця звернулася дружина ветерана С. Вона розповіла, що після повернення чоловіка В. з фронту пів року тому, життя в родині стало нестерпним. В. щодня вживає алкоголь, під

час сп'яніння агресує, ображає її та дитину, кидає речі. Фізичного насильства (побоїв) ще не було, але С. дуже боїться за безпеку дитини. В. категорично відмовляється йти до психолога, заявляючи, що «в нього все нормально, а лікуватися треба їй».

Питання: Які дії фахівця є найбільш правильними та безпечними для клієнтки?

1. Фахівець має запропонувати С. організувати спільну зустріч із В., щоб обговорити його поведінку, вживання алкоголю та вплив конфліктів на дитину. Під час розмови доцільно переконати В. звернутися по психологічну допомогу або лікування залежності, а С. порадити тимчасово уникати загострення конфліктів удома.

2. Фахівець має зосередитися на безпеці С. та дитини: оцінити ризики, допомогти скласти індивідуальний план безпеки, надати контакти служб допомоги, гарячої лінії 1547, шелтерів і мобільних бригад. Також слід роз'яснити алгоритм звернення до поліції у разі загрози та запропонувати С. психологічну й правову підтримку.

3. Фахівець має порадити С. спочатку зібрати більше доказів поведінки В., щоб у разі потреби мати підстави для офіційного звернення. Доцільно вести записи інцидентів, фіксувати свідчення дитини, зберігати фото пошкоджених речей і повернутися до питання звернення по допомогу, якщо насильство повториться або стане фізичним.

4. Фахівець має пояснити С., що робота з родиною можлива лише за згодою самого ветерана В., оскільки саме він є потенційним клієнтом Центру. Якщо В. відмовляється від психологічної допомоги чи супроводу, фахівець може надати С. загальні рекомендації щодо спілкування, але не має втручатися в сімейну ситуацію.

Термін виконання – 60 хвилин.

Комплексне кваліфікаційне (практичне) завдання №2

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Первинне звернення ветерана з множинними потребами

Опис ситуації:

До фахівця звернувся ветеран К., який просить допомогти лише з відновленням посвідчення учасника бойових дій, втраченого під час переїзду. У процесі розмови з'ясовується, що він тимчасово проживає у знайомих, має проблеми зі здоров'ям після поранення, не працює, уникає спілкування з родиною та не знає, куди звертатися щодо реабілітації. Ветеран роздратований і каже: «Мені не потрібні ваші анкети, просто скажіть, де відновити документ».

Питання: Яка послідовність дій фахівця є найбільш професійною?

1. Фахівець має обмежитися запитом К. і надати йому адресу установи для відновлення посвідчення. Інші питання не слід порушувати, оскільки ветеран чітко визначив, що саме йому потрібно, а додаткове опитування може викликати недовіру.
2. Фахівець має пояснити К., що без повного оцінювання потреб допомога не може бути надана. Якщо ветеран відмовляється заповнювати анкету, доцільно припинити консультацію та запропонувати повернутися тоді, коли він буде готовий до співпраці.
3. Фахівець має почати з актуального запиту ветерана щодо відновлення посвідчення, спокійно пояснити мету уточнення додаткових обставин, запропонувати мінімальне первинне оцінювання потреб і визначити разом із К. першочергові кроки: документ, медичний маршрут, житлове питання та можливі соціальні послуги.
4. Фахівець має одразу перенаправити К. до психолога, оскільки роздратування, соціальна ізоляція та небажання заповнювати документи свідчать про психологічну проблему, яку фахівець із супроводу самостійно вирішувати не повинен.

2. Дистанційне звернення члена сім'ї ветерана

Опис ситуації:

До фахівця телефонує мати ветерана Л. Вона повідомляє, що син після повернення зі служби майже не виходить з дому, не відповідає на дзвінки друзів, відмовляється звертатися по допомогу. Мати просить надати їй повну інформацію про пільги, реабілітаційні програми та статус сина у реєстрах, щоб «самій усе оформити за нього». Довіреності або письмової згоди Л. вона не має.

Питання: Як має діяти фахівець?

1. Фахівець має надати матері повну інформацію про сина, оскільки вона є близькою родичкою і фактично діє в його інтересах. У кризовій ситуації родина має право отримувати необхідні дані без додаткових процедур.
2. Фахівець має відмовити матері у будь-якому консультуванні, оскільки звернувся не сам ветеран. Доцільно повідомити, що робота можлива лише після особистого звернення Л. до Центру.
3. Фахівець має надати матері загальну інформацію про доступні послуги та можливі маршрути підтримки без розголошення персональних даних Л., пояснити порядок отримання згоди або представництва, а також запропонувати безпечний спосіб встановлення контакту з ветераном.
4. Фахівець має самостійно зателефонувати Л., повідомити йому, що мати зверталася до Центру, і наполягати на його явці для оцінювання потреб, оскільки ситуація може погіршуватися.

3. Комунікація з ветераном, який має порушення слуху

Опис ситуації:

На прийом прийшов ветеран Р., який має значне порушення слуху після поранення. Разом із ним прийшла неповнолітня донька, яка намагається перекладати розмову. Під час консультації потрібно обговорити питання медичної реабілітації, фінансової допомоги та складних сімейних обставин. Донька каже, що «тато звик, я завжди за нього відповідаю».

Питання: Який підхід є найбільш етичним і професійним?

1. Фахівець має дозволити доньці перекладати всю розмову, оскільки вона добре знає батька і може швидше пояснити його потреби. Це допоможе уникнути зайвих організаційних труднощів.
2. Фахівець має припинити консультацію, оскільки без професійного перекладача жестової мови або спеціальних технічних засобів неможливо забезпечити належну якість супроводу.
3. Фахівець має звертатися безпосередньо до Р., з'ясувати зручний для нього спосіб комунікації, забезпечити конфіденційність, за потреби організувати перекладача або інші засоби доступної комунікації, не покладаючи обов'язок перекладу складної та конфіденційної інформації на дитину.
4. Фахівець має спочатку опитати доньку про всі потреби батька, а потім попросити Р. лише підтвердити правильність відповідей письмово.

4. Сумнівна інформація про виплати

Опис ситуації:

Ветеранка М. звернулася до фахівця з повідомленням, що в соціальних мережах поширюється інформація про «разову виплату для всіх демобілізованих». Для отримання коштів потрібно заповнити онлайн-форму, додати фото паспорта, ідентифікаційного коду та банківської картки. М. уже надіслала посилання кільком знайомим ветеранам і просить фахівця «підтвердити, що це справжня програма».

Питання: Яка дія фахівця є правильною?

1. Фахівець має порадити М. заповнити форму, якщо сайт виглядає офіційно, адже остаточне рішення про передачу персональних даних ухвалює сама особа.
2. Фахівець має самостійно відкрити форму, внести тестові дані та перевірити, чи справді після цього надходить підтвердження про виплату.
3. Фахівець має перевірити інформацію через офіційні джерела, попередити М. про ризики шахрайства та передачі персональних даних, надати безпечний алгоритм перевірки соціальних виплат і рекомендувати не поширювати неперевірене посилання.
4. Фахівець має проігнорувати ситуацію, оскільки поширення інформації в соціальних мережах не належить до сфери професійної діяльності фахівця із супроводу.

5. Ветеран відмовляється від реабілітації після поранення

Опис ситуації:

Ветеран П. після поранення отримав направлення на реабілітацію, але не з'явився на прийом до лікаря та не відповідає на дзвінки медичного закладу. Під час зустрічі з фахівцем він говорить: «Немає сенсу, все одно як раніше не буде». Його дружина просить фахівця «натиснути на нього», бо родина виснажена і не знає, як переконати П. лікуватися.

Питання: Які дії фахівця є найбільш доцільними?

1. Фахівець має чітко повідомити П., що відмова від реабілітації є безвідповідальною щодо себе і родини. Доцільно залучити дружину, щоб вона контролювала відвідування лікарів.
2. Фахівець має зафіксувати відмову П. від реабілітації та завершити супровід за цим напрямом, оскільки доросла людина сама відповідає за власне здоров'я.

3. Фахівець має провести спокійну розмову з П., з'ясувати причини відмови, актуальний психологічний стан і бар'єри доступу до послуг, запропонувати переглянути індивідуальний план підтримки, залучити медичного фахівця, психолога або ветеранського наставника за згодою П.

4. Фахівець має передати інформацію про стан П. усім членам родини, щоб вони спільно вплинули на його рішення та забезпечили проходження реабілітації.

6. Запит роботодавця на інформацію про ветерана

Опис ситуації:

До фахівця звертається роботодавець, який планує взяти на роботу ветерана Н. Роботодавець просить повідомити, чи має Н. поранення, психологічні труднощі, статус інвалідності та чи «не буде він конфліктним у колективі». Він пояснює, що хоче уникнути ризиків і правильно організувати робоче місце.

Питання: Яка відповідь фахівця є найбільш професійною?

1. Фахівець має надати роботодавцю всю відому інформацію про Н., адже це допоможе уникнути конфліктів і забезпечити адаптацію ветерана на робочому місці.

2. Фахівець має відмовитися від будь-якої комунікації з роботодавцем, оскільки працевлаштування не стосується супроводу ветеранів.

3. Фахівець має пояснити роботодавцю принцип конфіденційності, не розголошувати персональні чи медичні дані без згоди Н., але може надати загальні рекомендації щодо етичної комунікації, недискримінації та адаптації робочого місця.

4. Фахівець має порадити роботодавцю провести неформальну співбесіду з родичами Н., щоб отримати більше інформації про його поведінку й стан здоров'я.

7. Представники медіа просять «історію успіху»

Опис ситуації:

Місцеве медіа готує сюжет про підтримку ветеранів у громаді. Журналіст просить фахівця надати контакти кількох ветеранів, які проходили супровід, а також коротко описати їхні історії: поранення, сімейні обставини, проблеми з роботою та результати допомоги. Журналіст обіцяє «показати все позитивно» і не бачить у цьому проблеми.

Питання: Як має діяти фахівець?

1. Фахівець має надати журналісту контакти ветеранів, адже позитивні історії сприятимуть розвитку ветеранської політики в громаді.

2. Фахівець має передати журналісту лише ті історії, які здаються йому найбільш мотивуючими, але без точних адрес і номерів телефонів.

3. Фахівець має відмовитися від будь-якої співпраці з медіа, оскільки публічність завжди шкодить ветеранам і порушує їхні права.

4. Фахівець може запропонувати медіа узагальнену знеособлену інформацію про роботу Центру, а участь конкретних ветеранів можлива лише за їхньою добровільною, поінформованою згодою та з правом відмовитися від публічності на будь-якому етапі.

8. Конфлікт інтересів під час надання допомоги

Опис ситуації:

До фахівця звернувся ветеран І., який є його сусідом і давнім знайомим родини. І. просить допомогти йому отримати місцеву матеріальну допомогу позачергово, пояснюючи, що «ти ж знаєш мою ситуацію». Фахівець справді знає, що І. має фінансові труднощі, але також знає, що в громаді є інші ветерани з не менш складними обставинами.

Питання: Які дії фахівця відповідають професійній етиці?

1. Фахівець має допомогти І. позачергово, оскільки особисто знає його життєву ситуацію і може підтвердити її достовірність.

2. Фахівець має пояснити наявність потенційного конфлікту інтересів, надати загальну інформацію про порядок отримання допомоги, допомогти підготувати документи без надання переваг і за потреби передати супровід іншому фахівцю.

3. Фахівець має відмовити І. у консультації, оскільки будь-яке знайомство з клієнтом автоматично забороняє професійну взаємодію.

4. Фахівець має прийняти документи І. самостійно, але не повідомляти колегам про особисте знайомство, якщо він не планує порушувати чергу.

9. Ведення обліку ветеранів та перевірка інформації

Опис ситуації:

До фахівця звернувся представник громадської організації, яка реалізує проєкт підтримки ветеранів. Він передає фахівцю таблицю з прізвищами ветеранів громади, номерами телефонів, інформацією про поранення, інвалідність, потребу в матеріальній допомозі та сімейні обставини. Частина даних ГО отримала з відкритих дописів у соціальних мережах, частину – від сусідів і волонтерів. Представник просить фахівця внести ці дані до робочого реєстру Центру, щоб «не витрачати час на повторне опитування» і швидше сформувати список тих, кому потрібна допомога.

Питання: Яка дія фахівця є найбільш правильною щодо обліку та використання отриманої інформації?

1. Фахівець має внести всі дані до реєстру, оскільки інформація надана партнерською організацією з метою допомоги ветеранам. Надалі ці відомості можна використовувати для планування соціальних послуг і розподілу підтримки.

2. Фахівець має прийняти таблицю лише як орієнтовну інформацію, але не вносити персональні та чутливі дані до реєстру без перевірки їх достовірності, законних підстав для обробки та згоди осіб. Доцільно використовувати знеособлені узагальнені дані для планування, а індивідуальну роботу розпочинати після належного звернення або підтвердження згоди ветерана.

3. Фахівець має відмовитися від будь-якої співпраці з громадською організацією, оскільки дані зібрані не державним органом. Подальша взаємодія з ГО може створити ризики порушення конфіденційності.

4. Фахівець має внести до реєстру лише ті дані, які стосуються матеріального стану ветеранів, а інформацію про поранення, інвалідність і сімейні обставини залишити в окремому файлі для внутрішнього користування.

10. Міжвідомча взаємодія у складному випадку

Опис ситуації:

До фахівця звернулася ветеранка Н., яка самостійно виховує двох дітей. Після демобілізації вона не може працевлаштуватися, має борги за оренду житла, потребує медичної реабілітації після поранення, а молодша дитина має труднощі в навчанні та потребує консультації спеціалістів. Н. уже зверталася до кількох установ, але всюди отримувала відповідь: «Це не до нас». Вона виснажена, говорить, що більше не має сил «ходити по кабінетах», і просить фахівця сказати, куди їй звернутися першочергово.

Питання: Який алгоритм дій фахівця є найбільш професійним у цій ситуації?

1. Фахівець має надати Н. перелік установ із телефонами та адресами, пояснивши, що кожна установа відповідає лише за свій напрям. Подальше звернення до цих установ є відповідальністю самої ветеранки.

2. Фахівець має визначити найгострішу проблему, а саме борг за житло і зосередити супровід лише на цьому питанні. Інші потреби варто розглядати після стабілізації житлової ситуації.

3. Фахівець має провести комплексне оцінювання потреб Н. та дітей, визначити першочергові ризики, погодити з нею індивідуальний план супроводу, організувати міжвідомчу взаємодію із соціальними службами, медичним закладом, службою зайнятості, освітніми/психолого-педагогічними фахівцями та здійснювати моніторинг виконання домовленостей.

4. Фахівець має порадити Н. звернутися до благодійної організації, оскільки державні установи не завжди можуть швидко реагувати на комплексні випадки. Після отримання благодійної допомоги можна повернутися до оформлення офіційних послуг.

Термін виконання – 60 хвилин.